



GUIA PARA PACIENTES

Dedo em gatilho

por que o dedo trava e o que fazer

Por que o dedo estala e prende, o que você pode fazer agora, o que se sabe da infiltração e da cirurgia, e quais sinais não podem esperar.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **GATILHO**

Para quem é:

Para adultos com um dedo (ou o polegar) que **estala, prende ou trava** ao dobrar, com dor na palma da mão, na base desse dedo, **sem queda, batida ou corte** e **sem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- **Crianças**. O dedo em gatilho infantil tem causas e tratamento próprios [2].
- Quem tem **artrite reumatoide**. O tratamento pode ser diferente (Página 9) [2]. Leia o guia, mas converse com seu médico antes de seguir o plano.
- Quem operou a mão há pouco tempo: siga a orientação da sua equipe.

O que você vai precisar:

- Este guia e uma caneta para o rastreador da Página 7.
- Uma tala, **se** já foi orientada por médico ou terapeuta da mão.
- Espuma ou fita para engrossar cabos de objetos (Página 6).

Regra de ouro:

Dedo travado se solta **devagar**, nunca no tranco.

Se ele não solta com delicadeza, **não force**: procure avaliação.

O dedo em gatilho não é grave. Mas alguns quadros parecidos são. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure atendimento HOJE (pronto-socorro) se:

- O dedo inteiro está **inchado por igual, vermelho e quente**, fica **dobrado**, dói muito **ao tentar esticar** e dói ao apertar a parte da frente do dedo, **com ou sem febre**. Isso pede ainda mais atenção depois de **ferimento, espinho, mordida ou injeção**. Pode ser **infecção da bainha do tendão**, uma urgência: o atraso pode causar perda de movimento e, nos casos graves, até amputação [4][5].
- Depois de um **corte** na mão, você **não consegue dobrar** o dedo ou a ponta dele. Pode ser tendão cortado (opinião clínica).
- Depois de **queda ou batida**, o dedo ficou **torto, roxo ou muito inchado** (opinião clínica).

Procure avaliação em poucos dias se:

- O dedo **travou dobrado e não estica**, nem com ajuda delicada da outra mão (Página 5).
- Há **formigamento ou dormência** nos dedos, principalmente à noite. O túnel do carpo é comum em quem tem dedo em gatilho [1].
- **Várias articulações** incharam ou amanhecem rígidas. Pode haver doença reumática por trás (opinião clínica).

Observação honesta: esses sinais não provam doença grave. Eles dizem quem precisa ser examinado antes.

Um tendão que passa apertado por um anel

Os tendões que dobram os dedos correm por um túnel preso ao osso por **polias**, como os anéis de uma vara de pescar. A primeira delas, a **polia A1**, fica na palma, na altura da base do dedo.

No dedo em gatilho há uma **desproporção entre o tendão e essa polia**: o tendão engrossa, às vezes formando um nódulo, e a polia fica mais espessa. Ao dobrar o dedo, o tendão passa com dificuldade pelo anel e "dispara", como o gatilho de uma arma [1][2].

Como costuma aparecer

- Dor na palma, na base do dedo, às vezes com um **nódulo** que você sente ao apertar.
- Estalo, "engasgo" ou travamento ao dobrar e esticar.
- Rigidez de manhã, ou **acordar com o dedo travado** [1].

Quem tem mais

- **Mulheres**, principalmente entre os 50 e os 60 anos. Numa revisão, 75% dos casos eram mulheres [1][3].
- **Diabetes**: o risco ao longo da vida, de 2% a 3% na população, chega a cerca de 10% em diabéticos [1].
- Quem tem **artrite reumatoide**, **túnel do carpo**, hipotireoidismo ou doença renal [1].

A causa exata nem sempre é conhecida. O atrito repetido entre o tendão e a polia parece contribuir [1].

Os ortopedistas costumam classificar o dedo em gatilho por graus. A classificação de Quinnell, modificada por Green, é a mais usada pelos ortopedistas brasileiros [7]. Em linguagem simples [6]:

- **Grau 0:** movimento normal.
- **Grau 1:** o dedo dobra de forma irregular, "engasgada", mas **não trava**.
- **Grau 2:** o dedo **trava, e você mesmo destrava** esticando o próprio dedo.
- **Grau 3:** o dedo trava e **só destrava com ajuda da outra mão**.
- **Grau 4:** o dedo fica **preso**, dobrado, e não estica nem com ajuda.

Por que o grau importa

Ele ajuda a escolher o tratamento, mas **não decide sozinho**.

- A tala foi estudada principalmente nos **graus 1 e 2**, com sintomas de **menos de 3 meses** [10].
- A infiltração costuma funcionar melhor em quadros **recentes** e em quem **não tem diabetes** [1][14].
- O grau 4 e os casos que voltam muitas vezes costumam levar à discussão cirúrgica (Página 9). É uma tendência da prática, não uma regra (opinião clínica).

Também contam: há quanto tempo o dedo trava, quantos dedos estão afetados, diabetes, artrite e o quanto isso atrapalha a sua rotina.

Anote o seu grau de hoje. Você vai compará-lo ao fim do plano da Página 7.

Antes de começar: a tala tem estudos pequenos, com resultado favorável em parte dos pacientes (evidência baixa a moderada) [8][9][10]. As medidas 2 e 3 são **opinião clínica**. Nenhuma garante resultado.

Medida 1 — Tala noturna

Como fazer: use à noite, por cerca de 6 semanas, uma tala que mantenha **reta a base do dedo**, onde ele se junta à mão. O ideal é que seja indicada por médico ou terapeuta da mão [8][9][10].

Sensação correta: firme e confortável, sem formigar e sem a ponta do dedo ficar roxa ou pálida.

Erro comum: tala apertada ou improvisada com fita enrolando o dedo inteiro.

Medida 2 — Poupar o aperto forte

Como fazer: por algumas semanas, reduza a pegada forte e repetida: alicate, tesoura de poda, torcer pano, sacola pesada nos dedos. Engrosse cabos com espuma. No resto, use a mão normalmente.

Sensação correta: menos dor na palma no fim do dia.

Erro comum: imobilizar a mão inteira ou deixar de usá-la.

Medida 3 — Movimento suave, sem provocar o gatilho

Como fazer: de manhã, abra e feche a mão devagar, 10 vezes, **só até antes** do ponto em que o dedo prende.

Sensação correta: dedo "aquecendo", sem estalo.

Erro comum: fechar e abrir com força, várias vezes ao dia, para "testar" se ainda trava.

Semanas 1 e 2 — Começar

- Tala toda noite, se orientada.
- Poupar o aperto forte (Medida 2).
- Movimento suave pela manhã (Medida 3).

Semanas 3 e 4 — Observar

- Manter as três medidas.
- Se o dedo **passou a precisar da outra mão** para destravar, ou piorou, **não espere o fim do plano**: marque avaliação.

Semanas 5 e 6 — Comparar

- Compare a semana 6 com a semana 1 e reveja o seu grau (Página 5).
- Sem melhora clara: procure avaliação para discutir as outras opções (Páginas 8 e 9).

Seis semanas é o tempo de uso da tala nos estudos [9][10]; uma revisão sugere de 6 a 10 semanas [8]. Os demais detalhes do plano são orientação prática, não um protocolo testado.

Rastreador

	Travamentos por dia (média)	Dor na palma (0–10)	Dias em que acordou travado (0–7)	Noites com tala (0–7)
Semana 1				
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				
Semana 6				

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra a tendência, e não só o pior dia.

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Essa decisão depende do seu caso e é tomada na consulta.

A infiltração é uma injeção de corticoide junto ao tendão, na palma. Entre os ortopedistas brasileiros, é a escolha inicial mais comum, depois ou junto das medidas simples [7].

Funciona?

- A revisão Cochrane mostrou benefício em 4 semanas, mas reuniu **só 2 estudos pequenos**, de qualidade metodológica fraca [11].
- Outra revisão estimou sucesso em **cerca de 57%** dos pacientes [3].

O efeito dura?

- Num estudo com 5 a 10 anos de acompanhamento, **45%** resolveram com uma única infiltração. A maioria das falhas veio nos 2 primeiros anos [12].
- Uma segunda ou terceira infiltração deu alívio duradouro em **cerca de 39%** dos dedos [13].
- Comparada à cirurgia aberta, a infiltração teve **mais retorno do gatilho** em 6 a 12 meses: cerca de 38 em cada 100 pessoas, contra 6 em 100 (evidência de baixa qualidade) [15].

Diabetes muda a conta

Em diabéticos, a infiltração funciona **menos** do que em não diabéticos [2] [14].

Riscos

Afinamento ou clareamento da pele, perda de gordura no local, **aumento passageiro da glicose em diabéticos** e infecção. A ruptura do tendão é muito rara [1].

Quando se discute

Quando as medidas simples e a infiltração não resolvem, quando o gatilho volta repetidamente ou quando o dedo está preso (grau 4). O **momento certo é controverso**: há quem indique a cirurgia depois de uma infiltração sem sucesso e há quem tente mais de uma [1].

O que se faz

A cirurgia **abre a polia A1** para o tendão voltar a deslizar [2]. Há duas formas:

- **Aberta**: um pequeno corte na palma.
- **Percutânea**: a polia é liberada com uma agulha, pela pele, sem corte aberto.

O que os estudos mostram

- O sucesso relatado da cirurgia aberta fica entre **90% e 100%** [1].
- Nas metanálises, aberta e percutânea tiveram **resultados semelhantes** de sucesso, complicações e dor [15][16][17].
- Na primeira semana, a cirurgia dói mais do que a infiltração [15].

Riscos

São raros: lesão de nervo do dedo (preocupação maior na técnica percutânea), infecção, dor na cicatriz, gatilho persistente e o tendão "em corda de arco" [1][2]. Nenhuma cirurgia tem resultado garantido.

Artrite reumatoide

Nesses pacientes, em geral **não se abre a polia A1**: o tratamento costuma ser outro, a limpeza da membrana inflamada do tendão [2]. Por isso a avaliação é individual.

1. Destravar o dedo no tranco.

Puxar com violência ou "estalar" o dedo de propósito costuma aumentar a dor na palma. Se precisar da outra mão, estique devagar. Se não soltar, não force (opinião clínica).

2. Testar o gatilho o dia inteiro.

Fechar e abrir a mão com força só para ver se ainda trava repete o atrito que alimenta o problema (opinião clínica, coerente com a Página 4) [1].

3. Improvisar tala apertada.

Tala malfeita machuca a pele e prende a circulação. A que tem estudo é a que deixa reta a base do dedo [8][9].

4. Repetir infiltração sem reavaliar.

Cada nova tentativa tem chance menor de resolver por longo prazo [1][12][13], e em diabéticos o resultado já é menor [14]. Se o gatilho voltou, vale reavaliar o plano em vez de só repetir.

5. Conviver meses com o dedo preso.

Dedo travado dobrado por muito tempo tende a perder a capacidade de esticar por completo, e a recuperação fica mais difícil (opinião clínica).

Bônus: achar que a cirurgia é sempre o primeiro passo.

A maioria dos ortopedistas começa pelo tratamento sem cirurgia [7]. Mas, quando ela é indicada, adiar demais também tem custo.

Procure avaliação se:

- Não houve **melhora clara após as 6 semanas** do plano da Página 7.
- O dedo **só destrava com ajuda da outra mão** (grau 3) ou **ficou preso** (grau 4).
- **Mais de um dedo** está travando, ou você tem **diabetes** ou **artrite reumatoide**.
- A dor ou o travamento atrapalham o trabalho, o sono ou as tarefas da casa.
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

O prazo de 6 semanas vem do tempo de uso da tala nos estudos [9][10]. É um ponto de referência, não uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

Na maior parte dos casos, o diagnóstico é feito **pela conversa e pelo exame físico**, sem exame de imagem [7]. Na consulta, examino o nódulo, o grau de cada dedo, a mão inteira e o punho, porque o túnel do carpo pode estar junto [1].

Na minha prática: avalio, oriento e posso tratar as fases iniciais, com tala e infiltração quando indicada. **Quando a cirurgia é o caminho, encaminho a um cirurgião de mão.** Isso faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: [@robertorodriguesmd](https://www.instagram.com/robertorodriguesmd)

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Makkouk AH, Oetgen ME, Swigart CR, Dodds SD. **Trigger finger: etiology, evaluation, and treatment.** Curr Rev Musculoskelet Med. 2008;1(2):92-96. doi:10.1007/s12178-007-9012-1. PMID: 19468879.
2. Ryzewicz M, Wolf JM. **Trigger digits: principles, management, and complications.** J Hand Surg Am. 2006;31(1):135-146. doi:10.1016/j.jhsa.2005.10.013. PMID: 16443118.
3. Fleisch SB, Spindler KP, Lee DH. **Corticosteroid injections in the treatment of trigger finger: a level I and II systematic review.** J Am Acad Orthop Surg. 2007;15(3):166-171. doi:10.5435/00124635-200703000-00006. PMID: 17341673.
4. Kennedy CD, Huang JI, Hanel DP. **In Brief: Kanavel's Signs and Pyogenic Flexor Tenosynovitis.** Clin Orthop Relat Res. 2016;474(1):280-284. doi:10.1007/s11999-015-4367-x. PMID: 26022113.
5. Pang HN, Teoh LC, Yam AK, Lee JY, Puhaindran ME, Tan AB. **Factors affecting the prognosis of pyogenic flexor tenosynovitis.** J Bone Joint Surg Am. 2007;89(8):1742-1748. doi:10.2106/JBJS.F.01356. PMID: 17671013.
6. Langer D, Maeir A, Michailovich M, Luria S. **Evaluating Hand Function in Clients with Trigger Finger.** Occup Ther Int. 2017;2017:9539206. doi:10.1155/2017/9539206. PMID: 29097982.
7. Silva PHJD, Moraes VY, Segre NG, Sato ES, Faloppa F, Belloti JC. **Diagnosis and Treatment of Trigger Finger in Brazil - A Cross-Sectional Study.** Rev Bras Ortop (Sao Paulo). 2021;56(2):181-191. doi:10.1055/s-0040-1721363. PMID: 33981124.
8. Lunsford D, Valdes K, Hengy S. **Conservative management of trigger finger: A systematic review.** J Hand Ther. 2019;32(2):212-221. doi:10.1016/j.jht.2017.10.016. PMID: 29290504.
9. Tarbhai K, Hannah S, von Schroeder HP. **Trigger finger treatment: a comparison of 2 splint designs.** J Hand Surg Am. 2012;37(2):243-249. 249.e1. doi:10.1016/j.jhsa.2011.10.038. PMID: 22189188.
10. Drijckoningen T, van Berckel M, Becker SJE, Ring DC, Mudgal CS. **Night Splinting for Idiopathic Trigger Digits.** Hand (N Y). 2018;13(5):558-562. doi:10.1177/1558944717725374. PMID: 28825334.
11. Peters-Veluthamaningal C, van der Windt DA, Winters JC, Meyboom-de Jong B. **Corticosteroid injection for trigger finger in adults.** Cochrane Database Syst Rev. 2009;(1):CD005617. doi:10.1002/14651858.CD005617.pub2. PMID: 19160256.
12. Wojahn RD, Foeger NC, Gelberman RH, Calfee RP. **Long-term outcomes following a single corticosteroid injection for trigger finger.** J Bone Joint Surg Am. 2014;96(22):1849-1854. doi:10.2106/JBJS.N.00004. PMID: 25410501.
13. Dardas AZ, VandenBerg J, Shen T, Gelberman RH, Calfee RP. **Long-Term Effectiveness of Repeat Corticosteroid Injections for Trigger Finger.** J Hand Surg Am. 2017;42(4):227-235. doi:10.1016/j.jhsa.2017.02.001. PMID: 28372638.
14. Baumgarten KM, Gerlach D, Boyer MI. **Corticosteroid injection in diabetic patients with trigger finger. A prospective, randomized, controlled double-blinded study.** J Bone Joint Surg Am. 2007;89(12):2604-2611. doi:10.2106/JBJS.G.00230. PMID: 18056491.
15. Fiorini HJ, Tamaoki MJ, Lenza M, Gomes Dos Santos JB, Faloppa F, Belloti JC. **Surgery for trigger finger.** Cochrane Database Syst Rev. 2018;2(2):CD009860. doi:10.1002/14651858.CD009860.pub2. PMID: 29460276.
16. Wang J, Zhao JG, Liang CC. **Percutaneous release, open surgery, or corticosteroid injection, which is the best treatment method for trigger digits?** Clin Orthop Relat Res. 2013;471(6):1879-1886. doi:10.1007/s11999-012-2716-6. PMID: 23208122.
17. Casey JC, Daher M, Dworkin M, Cusano J, Garavito J, Gil JA. **Open Versus Percutaneous Fixation of Trigger Finger: Meta-Analysis of Clinical Outcomes.** J Hand Surg Am. 2024;49(6):570-575. doi:10.1016/j.jhsa.2024.03.010. PMID: 38727666.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765